

네 번째 강의

흉복요배부 촉진 강의

1. 흉부

체크 포인트

-앉은 자세-

① 쇄골: 만져보면서 측정하기 -> 양쪽 쇄골이 대칭인 사람은 드물
특히 성인의 경우 대부분 어깨가 휘어있음

② 흉골: 몸체 ~ 흉골병까지를 눌러보면서 확인

+) 흉골 기준으로 어깨까지 양쪽 어디가 더 넓은지 (대칭)

③ 갈비뼈: 흉골 아래쪽으로 모양을 확인

+) 늑골이 이루는 각 확인하기 (90도 기준으로 더 넓은지/좁은지. 90도면 상당히 넓은 편)

④ 가슴: 어느 쪽이 더 튀어나와 있는지 (흉골병이 튀어나왔으면 새가슴 / 흉골병이 안쪽으로 들어가있으면 함몰흉 / 흉골 부근이 평평하면 편평흉)

+) 유방의 높이

호흡: 환자가 모르게 측정하기

-누운 자세-

① 쇄골: 누워서 보는 것이 더 잘 드러남

② 흉골: 앉았을 때와 달리 높낮이가 비대칭임을 확인할 수도 있음

③ 갈비뼈: 높이가 어떤지 확인

+) 갈비뼈 늑골 연골의 탄성도: 손바닥으로 눌러서 확인

(오른쪽과 왼쪽의 저항감, 얼마나 들어가는지를 비교)

-> 저항감이 더 큰건 그쪽 갈비사이공간이 더 좁아져 있는 것

+) 누워서 보면 갈비뼈와 흉골의 결합 확인이 더 용이해짐

가슴: 크기 차이가 더 도드라지게 보일 수 있음

① 청진

(누운 자세로 함)

- 벨 부분을 막고 막 부분(멤브레인 - 더 넓은 부분)으로 듣도록 함

- 막 부분으로 들을 땐 밀착하고, 쓸리게 움직이지 않아야 함

- 벨은 흉부/복부의 깊은 부분을 확인하는 데 사용

- 먼저 멤브레인으로 듣는 것이 좋음 (벨은 소리가 작기 때문)

호흡음

- 심음이 배제되어야 잘 들림

- 첫 번째와 두 번째 갈비뼈의 사이에 대고 듣기 (사진 참고)



- 심호흡을 크게 하도록 하여서 들어보기

- 양 쪽을 듣기 (3-5회의 호흡음을 들어야 함)

심음

- 일반적으로 멤브레인(막혀있는 부분) 부분으로 함
- 심음 청진으로 무언가를 알기는 어렵고 규칙성 정도 파악
- S1, S2를 균일하게 들을 수 있는 부분: 왼쪽 3번째 늑간
- > 여기서 S1과 S2를 구분해야 함
- S1: 크고 끊어지는 느낌 -> 크게 들리는게 S1
- S2: 작고 덜 들리는 것 -> 작게 들리는게 S2



② 타진



- 알 수 있는 것이 거의 없음 (just 연습)
- 간의 위치를 찾는 연습을 할 것 (폐와 복부의 중간에 위치)
- 폐: 때렸을 때 맑은 소리가 남
- 간: 탁한 소리가 남
- 폐에서 시작해서 밑으로 내려가면서 저렇게 툭툭치면서 소리 확인 (위 사진 참고)
- 3-5cm 깊이 정도만 타진을 통해 알 수 있음
- 실제 간은 훨씬 더 클 것 (안 들리는 부분도 포함되기 때문)



- -이렇게 위의 위치로 추정되는 부분의 사진도 들어보면서 소리를 비교하기
- 차 있는 소리 / 비어 있는 소리
- 심장과 겹쳐 있는 부분의 소리 등 소리의 차이를 느껴보기

2. 흉부

체크 포인트

- 이루고 있는 경계 확인
- 갈비뼈/장골능
- 정중선을 기준으로 대칭성을 확인 (배꼽이 중간에 있는지, 좌우의 팽윤 차이, 색깔, 정맥의 확장, 점, 수술 흔적, 갈비뼈 등)
- 호흡할 때 복부의 움직임 (장의 연동운동이 보이면 건강하지 않은 상태임)
- 탄력을 확인하기 (가볍게 대었을 때 제 위치로 다시 돌아오는지 정도만 확인)
- 수직선상에서 검상돌기 ~ 배꼽 ~ 치골 상연의 위치가 일직선인지
- 치골상연의 위치는 만지기 부담스러우니 머뭇거리면 안됨. or 환자 자신의 손을 이용해서 같이 찾기
- 누워있을 때 찾아보기 좋은 곳은 늑골 하연과 장골능 사이의 공간!
- > 양쪽의 공간이 어떻게 다른지 확인

① 청진 (알 수 있는 것이 별로 없음. 연동운동을 하고 있구나 정도)

- '꼬로록꼬로록'하는 소리가 멤브레인을 통해서 들림
- > 1분 내에 꼬로록 소리가 하나도 안 들리면 문제(장폐색)가 있는 것
- 5군데 정도 선택 (3주차 영상(1)에 이론 파트 2p 참고)
- > 각 위치마다 호흡을 3번씩 하도록 하기
- 15번의 호흡을 1분 정도의 시간 동안 들어보기
- > 연동운동 / 꼬르륵 소리 몇 번 들리는지 (5-20회 정도가 정상)
- > 너무 많이 들려도 설사나 감염 의심 가능
- > 규칙적으로 들리는 음이 있으면 거의 동맥의 소리 (특히 복대동맥 /

대퇴동맥)

② 촉진 (센 힘으로 누르지 않는 것이 중요)

- -한 손 및 두 손을 사용하게 됨
- 가벼운 촉진: 1cm 정도 누르기
- 심부 촉진: 5cm 이상 누르지 않음
- 한 손: 체중으로 눌러서 덩어리가 있는지 정도만 확인 (환자의 얼굴을 같이 보면서 통증을 느끼는지 확인)
- 두 손: 심부촉진 (우리가 할 것) (아래 손의 손톱이 흰색이 되지 않게 하고 위 손으로 아래 손을 눌러줌)



- 배꼽 기준으로 좌우/상하 나누어서 확인하는게 좋음 + 경계선까지
- 위 사진과 같이 한 손으로 누르고 한 손으로 느낄 수 있도록 하기
- 간지러움을 호소하는 환자의 경우 환자의 손을 이용하여 하기 (아래 사진)





- 복수가 차있는지 확인: 사진처럼 환자보고 배 위를 손날을 이용하여 눌러달라고 한 후, 한쪽 손은 파동을 느끼고 한쪽 손은 파동을 줌
-> 복수가 있으면 물이 찰랑거리는 듯한 파동이 느껴짐 = fluid wave
- 눌렀다 떼었을 때 반동 압통(충수돌기염, 복막염 등에서 많이 느낌)이 느껴지는지 확인
- 짧은 시간 안에 끝내야 함 (환자들이 유쾌해하지 않기 때문)

3. 복모혈

- 12개가 다 의미가 있는 것은 아님
- 중부, 단중, 거결, 중완, 관원, 천추를 확인 -> 위치 정확히 확인
-> 중부 / 천추는 좌우 비교가 가능
-> 나머지는 점이 하나밖에 없어서 (대칭성 X) 비교가 어려움
-> 주위와 비교했을 때 혈자리 부위가 더 아픈지 확인
-> 더 자세히는 그 경혈(1번)과 그 경혈의 위아래 부분(2, 3번) 중 어디가 제일 아프세요'라고 물어보기

4. 흉복부 근육

① 소흉근

- 누운 자세 -



- 단축 시 누워있을 때 어깨가 뜨게 함
- 허리에 손을 집어 넣어 어깨를 앞으로 나오게 한 후 테이블을 뒤로 누르게 함
- 원하는 위치에 결의 수직 방향으로 손을 대고 힘을 주게 하면 느껴짐
- 반대쪽도 똑같이 실시하기
- 중부혈의 부위와 겹치는 부분이 있음 (폐경에 가까움)
- 모양이 제대로 안 나타나면 이미 소흉근이 단축되어 있는 것
- 통증을 느낄 수 있음
- 양쪽의 압통을 비교해보기

- 앞은 자세 -



- 오웬돌기에서 3, 4, 5 늑골 방향으로 내려가게 됨을 확인
- 대흉근으로 덮여있는 부분의 바깥쪽만 확인 가능
- 뒷짐을 지게 한 후 피시술자 손에 시술자의 손을 올려두기. 그 후 '손을 밀어보세요' 하면 튀어나옴

② 복직근



- 복횡근과 구분하기
- 고개를 들지 않은 상태에서 '배에 힘을 주세요'할 때 단축되는 근육은 복횡근만 (복직근은 호흡, 복압 상승에 관여 X)
- 고개를 들게 하면 복직근이 단축됨. 이를 통해 복직근 경계 확인
- 대부분은 배꼽 바로 위에서 좌우측의 융기 정도와 경직도를 비교하면 됨

③ 외복사근 / 내복사근 (정확히 촉진하긴 어렵고 대강의 위치만 파악)



= 만지는 쪽과 반대로 어깨를 비틀게 했을 때 느껴지는게 외복사근



- 만지는 쪽으로 어깨를 비틀게 했을 때 느껴지는게 내복사근
- 중요한 것은 내복사근의 경계선을 찾는 것.
-> 복직근과 내복사근 사이 공간을 찾고, 대요근 찾기 가능

④ 장요근 (장요근 - 대요근 + 소요근 + 장골근 / 이 중 대요근 찾기)

- T12 ~ L5까지 확인
- 내복사근, 복직근 사이를 촉진해야 함
- 누운 자세 -
- 무릎을 굽힌 상태에서 내복사근 복직근 사이 공간을 확인하고 손을 외하방 방향으로 깊게 누르기
- 숨을 크게 들이 쉬게 하고 그 상태로 완전히 멈춘 상태에서 확인
- > '무릎을 굽히세요' 하고 힘이 들어가게 함 -> 장요근 단축이 느껴짐
- 내복사근, 복직근 사이 공간에서 외측으로 확인



- 앉은 자세 - (촉진이 좀 더 쉽고, 누운 자세와 절차는 같음)
- 등을 약간 구부리게 하여 복부의 긴장감을 조금 없애야 함
- '숨을 들이쉬고 완전히 내쉬세요, 무릎을 들어올리세요' 하고 똑같이 내복사근과 복직근 사이 공간에서 촉진



5. 요배부

체크포인트

- 앉은 자세 -
 - 견갑골 상연, 하연, 견갑골 극 등으로 대칭 확인
 - 요추와 흉추를 구분 -> 늑골과 척추가 이루는 각인 늑척각 부근 신장 위치 (오른쪽이 간 때문에 좀 더 아래쪽에 위치하긴 함)
 - 흉터나, 피부의 두께 확인
- 옆드린 자세 -
 - 장골능 확인하기 (끝나는 부분에 psis가 있으니 위치 잘 찾기)
 - 옆드려 있을 때는 척추 측만 등이 두드러지지 않는
 - 천골이 안정적으로 좌우 대칭을 이루는지 확인
 - 근육/지방의 정도
- 선 자세 (뒷면) -
 - 중력을 얼마나 받아들이고 있는지 확인
 - 앉아 있을 때와 차이가 많으면 하지부의 문제가 있는 것
 - 견갑 상연, 하연, 내연, 양쪽 방광경근의 두께, 양쪽 엉덩이나 장골능, 천골의 모양 등을 비교
- 선 자세 (측면) -
 - 외이도 - 유양돌기 - 견봉 - 고관절의 후방 - 슬관절의 전방 - 발목 복사선 - 앞쪽 입방골의 관절이 일직선을 이루는지 확인
 - -> 이루면 이상적인 것 (대개 등이 굽어 있는 경우가 많음)

요추와 흉추의 운동성 (골반, 하지부 운동 최소화해서 확인)

① 굴곡, 신전



- 몸이 움직이지 않도록 사진과 같이 잡고 확인-
- 목은 안보고 흉추와 요추만 봄

② 회전



- 좌, 우 회전 시킨 후 얼마나 많이 움직이는지와 각각의 차이 확인

③ 측굴



- 측굴과 회전은 양쪽을 서로 비교해보기

6. 배수혈 (기준점 잘 확인하기)

- 유양돌기첨 C1
- 대추혈 C7
- 견갑골상연 T2, 3
- 견갑골하연 T7
- 검상돌기 T9
- 늑골하연 L2
- 배꼽 L3, 4
- 장골능 상연 L4

7. 요배부 근육

① 기립근군



- 기립근군의 경계선을 찾는 것은 사실상 불가능
- 목 인접 부근에서 구분하기는 더 어려움
- 목 아래로 구역을 나누어서 확인
- 구역: T1~7 / T7~ 늑척각 / 늑척각 아래 ~ 요추부 -> 좌우 비교
- 대부분 두께와 융기 정도만 확인
- PSIS를 찾고 그 위쪽 부분에 손을 댄 후 '고개를 들어보세요' 하면 기립근군의 수축이 일어남
- 양 쪽의 경직도와 통증의 유무를 확인하기
- 아래쪽에서 위쪽으로 올라가면서 좌우를 계속 확인하기 (고개 내렸다 드는 과정을 반복) -> 경결도 비교
- 아래쪽은 신전 시에 반응을 바로 하는데 위쪽은 끝까지 올려야 반응이 일어남
- 외측의 경계선이 어디까지 와있고 수축의 정도 확인하기 (어디가 더 커지는지)

- 아래 두 구역에 집중해서 볼 것

② 능형근 (소능형근 + 대능형근)

- 승모근 아래로 깊게 깔려 있음
- 운동을 하지 않는 사람은 능형근이 잘 커지지 않음

- 앉은 자세 -

- 승모근의 작용을 줄여야 하기 때문에 등 뒤로 손을 올리게 하고 '손 등을 등에서 떼세요' 하면 됨 (저항을 주지 않아도 능형근은 올라옴)



- '견갑골을 안으로 모아보세요' 해서 견갑골이 어느 정도까지 들어오는지 확인



- 엎드린 자세 -



- 앉은 것과 마찬가지로 방법으로 시행
- '손을 위로 들어보세요' 하면 수축하는 것이 보임
- 속도가 너무 빠르지 않게 시술자가 조절
- 승모근이 위에 덮여 있기 때문에 구분이 어려운데, 팔을 올리게 되면 승모근이 아닌 능형근에만 힘이 들어감

③ 요방형근

- 만진다는 의미보다는 압통이 어느 정도인지를 확인하기
- 공간이 좁기 때문에 안 만져지는 경우도 많음

- 엎드린 자세 -



- 위치 정도만 확인 (만지기 어려운 경우 존재)
- 숨을 완전히 내쉬 상태에서 확인하는 것이 좋음
- 몸을 들게 하여 척추 기립근 찾고 외복사근 찾아 촉진
- 척추기립근과 외복사근 사이에서 내측 하방으로 촉진
- '엉덩이를 올려보세요' 하면 단축됨